

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Γενικά: Πρόκειται για οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος και ιδιαιτέρως για φλεγμονή των πνευμόνων στην περιφέρειά τους, δηλαδή στους τελικούς αεραγωγούς, τις κυψελίδες και τον διάμεσο ιστό. Πνευμονία μπορεί να προκληθεί από πολλά και ποικίλα αίτια, όπως από εισρόφηση, με εισπνοή παθογόνων μικροοργανισμών ή αιματογενώς.

Αποτελεί την 6^η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. Οι συχνότερα εμπλεκόμενοι οργανισμοί είναι τα βακτηρίδια. Ο Πνευμονιόκοκκος ευθύνεται για το 60-85% του συνόλου των βακτηριδιακών πνευμονιών. Λεγεωνέλλα και αναερόβια μικρόβια είναι σπανιότερες αιτίες βακτηριακής πνευμονίας, ενώ η παρουσία αναερόβιων μικροβίων συχνά οφείλεται σε εισρόφηση.

Στους ασθενείς ηλικίας < 60 ετών, χωρίς υποκείμενες παθήσεις, συχνότερα αίτια πνευμονίας της κοινότητας, είναι τα κάτωθι:

- Streptococcus pneumoniae (30-60%).
- Haemophilus influenzae (5-10%).
- Chlamydia pneumoniae (4-6%).
- Legionella pneumophila (3-7%).
- Mycoplasma pneumoniae (1-6%).
- Staphylococcus aureus (3-5%).
- Αναερόβια μικρόβια (7-15%).
- Άλλα [*Moraxella*, Gram (-) αερόβιοι βάκιλλοι, ιοί] (5%).

Το κάπνισμα αποτελεί τον ισχυρότερο ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για πνευμονία της κοινότητας σε υγιείς ενήλικες. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση πνευμονίας της κοινότητας είναι: ηλικία > 60 ετών, συνοδά νοσήματα (ΑΥ, ΣΝ, ΣΚΑ, ΣΑτ2, ΧΝΝ, άνοια, χρόνια νευρολογική νόσος, χρόνια ηπατική νόσος, ανοσοκαταστολή), κλινοστατισμός, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Δύσπνοια, ταχύπνοια, βήχας, απόχρεμψη, πυρετός ή υποθερμία, φρίκια, ταχυκαρδία, θωρακικό (πλευριτικό) άλγος, εξωπνευμονικά συμπτώματα (έμετοι, διάρροιες, κοιλιακό άλγος, μυαλγίες, διαταραχές επιπέδου συνείδησης ιδίως σε Λεγεωνέλλωση, κ.ά.).

Ο ασθενής με πνευμονία προσέρχεται στο ΤΕΠ από περιπατητικός έως και σε κωματώδη κατάσταση· ενώ στη φυσική εξέταση και ακτινολογική διερεύνηση, μπορεί να παρουσιάζει:

- ✓ Κατά την ακρόαση του θώρακα, ήχους μη μουσικούς - υγρούς (τρίζοντες, υποτρίζοντες).
- ✓ Ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα ή σιγή (πιθανώς, τοπικά και ήχος τριβής).
- ✓ Σωληνώδες φύσημα (στο στάδιο ερυθράς και φαιάς ηπάτωσης λοβώδους πνευμονίας).
- ✓ Ποικίλη διακύμανση των φωνητικών δονήσεων (αύξηση ή μείωση).
- ✓ Επικρουστική αμβλύτητα, ειδικά στο σημείο και πέριξ της πυκνωτικής εστίας.
- ✓ Πλευριτική συλλογή (300-500 ml, ώστε να γίνει εμφανής στην ακτινογραφία θώρακος). Η ύπαρξη στην α/α θώρακος κοιλιοτήτων με υδραερικό επίπεδο, υποδηλώνει εγκυστωμένη συλλογή ή απόστημα και είναι συχνή σε πνευμονία από αναερόβια ή Gram (+) αερόβια.
- ✓ Σε πνευμονία από εισρόφηση πιθανώς να εμφανιστούν εστίες ή μικρά αποστήματα (στα οπίσθια τμήματα των άνω λοβών και στα κορυφαία τμήματα των κάτω λοβών). Οι άνω λοβοί ενίοτε προσβάλλονται σε περιπτώσεις πνευμονίας από *Klebsiella* ή σε φυματίωση.

Τα ευρήματα, από τον εργαστηριακό έλεγχο του ασθενούς, μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Λευκοκυττάρωση (ενίοτε με «αριστερή στροφή», δηλ. άωρες μορφές των WBCs).
- Λευκοπενία ή/και Θρομβοκυττάρωση (ιδίως σε λοίμωξη από *Legionella*).
- Αύξημένοι δείκτες φλεγμονής: TKE, CRP & Προκαλσιτονίνη-PCT (ακριβή εξέταση).
- Αύξηση τρανσαμινασών (συνήθως η ALT σε άτυπες πνευμονίες).
- Αύξηση αποφρακτικών ενζύμων (σε λοίμωξη από *Legionella*).
- Υπερχοληρυθριναιμία [ήπια, κυρίως άμεση (συζευγμένη)].
- Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (ΔΕΠ/DIC).
- Υποξαιμία, υποκαπνία και αναπνευστική αλκάλωση.
- Σε περίπτωση καταπληξίας (shock) παρατηρείται μεταβολική οξέωση.
- Πρωτεϊνουρία, πυουρία, αιματοουρία (νεφρίτιδα σε λοίμωξη από *Legionella*).
- Μυοσφαιρινουρία με οξεία νεφρική βλάβη (AKI σε λοίμωξη από *Legionella*).



Αξιολογούμε τη βαρύτητα της πνευμονίας και την πιθανότητα ο ασθενής να χρειαστεί εισαγωγή στο νοσοκομείο, με βάση την εύχρηστη κλίμακα **CURB-65**. Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα, για κάθε ένα από τα παρακάτω κλινικά δεδομένα δίνουμε έναν (1) βαθμό.

- ✓ **Confusion** (οξεία γνωσιακή έκπτωση ή Abbreviated Mental Test < 8/10)
- ✓ **Urea** ≥ 40 mg/dl ή **BUN** ≥ 19 mg/dl.
- ✓ **Respiratory rate (RR)** ≥ 30 /min.
- ✓ **Blood pressure** (Σ ΑΠ < 90 mmHg ή Δ ΑΠ < 60 mmHg).
- ✓ **Ηλικία** ≥ 65 ετών.



- **Βαθμός 0-1:** Θνητότητα 1,5%. Μπορεί να γίνει κατ' οίκον νοσηλεία και θεραπεία.
- **Βαθμοί 2:** Θνητότητα 9,2%. Χρειάζεται τουλάχιστον νοσοκομειακή επίβλεψη.
- **Βαθμοί ≥ 3 :** Θνητότητα 22%. Απαιτείται νοσηλεία σε νοσοκομείο και πιθανώς σε ΜΕΘ.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχονται τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*BP, HR, RR, SpO₂, T^oC, GCS*).
2. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει υπόταση, σύγχυση ή εμφανίζει CURB-65 score ≥ 2 , τοποθετούμε μάσκα οξυγόνου, με ροή στα 6-8 lt/min, ώστε SpO₂ > 90%, καθώς επίσης και φλεβική γραμμή με 1000 ml N/S ή R/S (στάγδην) και διακομίζουμε στο νοσοκομείο.
3. Η χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να ξεκινά εντός 2-4 ωρών από την άφιξη του ασθενούς στο ΚΥ ή το ΤΕΠ. Η αντιβιοτική αγωγή, αρχικά, είναι εμπειρική και πρέπει να στοχεύει τα κυριότερα παθογόνα. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αντοχή των μικροβίων, τη διεισδυτικότητα στο τραχειοβρογχικό δένδρο, την ηλικία, τη συννοσηρότητα, κ.λπ.
Σε υγιείς ενήλικες, χωρίς συννοσηρότητα και χωρίς προηγηθείσα χορήγηση αντιβιοτικών κατά το τελευταίο τρίμηνο, για κατ' οίκον θεραπεία ή νοσηλεία, χορηγείται συνδυασμός Αμοξυκιλίνης (1 g/6ωρο) με μια νεότερη Μακρολίδη (π.χ: Κλαριθρομυκίνη)· δηλαδή:
 - tab. **Amoxil** 1 gr, 1x4 (po), για 7 ημέρες, μαζί με
 - tab. **Klaricid/Claripen** 500 mg, 1x2 (po), για 7 ημέρες.Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί ο συνδυασμός Amoxi/Clav (ή μια Κεφαλοσπορίνη 3^{ης} γενεάς: π.χ: Κεφντιτορένη) μαζί με μία Μακρολίδη (π.χ: Αζιθρομυκίνη)· δηλαδή:
 - tab. **Augmentin** 1 gr ή sach. **Fugentin** 1 gr, 1x2 (po), για 7 ημέρες, ή αντ' αυτού tab. **Spectracef** 400 mg, 1x2 (po), για 5-7 ημέρες, μαζί με
 - caps. **Zithromax** 250 mg, 2x1 ή **Azirox** 500 mg, 1x1 (po), για 3 μόνον ημέρες.
4. Εφόσον έχει προηγηθεί - κατά το προηγούμενο τρίμηνο - λήψη κοινών αντιβιοτικών, από τον ασθενή, για οποιονδήποτε λόγο, τότε χορηγείται μια αναπνευστική Κινολόνη, όπως:
 - Λεβοφλοξασίνη (**Tavanic/ Evoxil**) tab. 500 mg, 1x1 ή 1x2 (po), για 7 ημέρες, ή
 - Μοξιφλοξασίνη (**Avelox/ Octegra**) tab. 400 mg, 1x1 (po), για 7 ημέρες.Αν αντίστροφα, το προηγούμενο τρίμηνο έχει χρησιμοποιηθεί Κινολόνη, τότε ως πρώτη επιλογή είναι ο συνδυασμός Αμοξυκιλίνης (7 ημέρες) με Μακρολίδη (3 ή 7 ημέρες).
5. Επίσης, για την κατ' οίκον θεραπεία και τη νοσηλεία ενηλίκων ασθενών με πνευμονία με συνοδό νοσηρότητα (*ΧΑΠ, ΣΝ-ΣΚΑ, ΣΔ, κακοήθεια, χρόνια νεφρική νόσος, αλκοολισμός, ηπατική ανεπάρκεια*) χρησιμοποιείται ο προειρημένος συνδυασμός Αμοξυκιλίνης και Μακρολίδης ή εναλλακτικά χορήγηση μιας Αναπνευστικής Κινολόνης (*ειδικά επί ΧΝΝ*).
6. Σε ενήλικες ασθενείς με υποψία εισρόφησης (π.χ. σε ασθενείς με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, όπως σε αλκοολισμό, χρήση ιν ναρκωτικών, επιληψία, ΑΕΕ, κ.λπ.), που είναι ηλικίας < 60 ετών και βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση, μπορεί να χορηγηθεί κατ' οίκον ο συνδυασμός Κεφουροξίμης με Κλινδαμυκίνη ή εναλλακτικά μια αναπνευστική Κινολόνη, όπως αναφέρθηκε. Διαφορετικά, απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο.
 - ▶ Κεφουροξίμη (**Zinadol/Nelabocin**) tab. 500 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες, μαζί με
 - ▶ Κλινδαμυκίνη (**Dalacin-C**) tab. 300 mg, 1x3 (po), για 7-10 ημέρες.